

走出集采与疫情影响，迈入创新兑现新纪元

2023年医药生物行业投资策略

证券分析师：张静含 A0230522080004

研究支持：余玉君 A0230522080005 仰佳佳 A0230522100005 凌静怡 A0230522060001

陈烨远 A0230521050001 王道 A0230121050002 李敏杰 A0230121070004

2022.12.14



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

- 截止至12月12日，今年以来申万医药生物指数累计涨跌幅为-15.6%，在31个申万一级行业中排名第16位，同期万得全A（除金融石油石化）累计涨跌幅为-15.9%，医药生物相对大盘涨跌幅为0.4%。9月末后受央行贴息贷款政策、江西IVD集采以及福建电生理耗材集采等多项政策事件驱动，叠加市场对于后续新冠管制政策预期变化，新冠诊疗、中成药等板块持续走强，医药生物板块与大盘整体涨跌幅差距较年中已大幅收窄。
- 截止至今年10月，全国规模以上医药制造业企业实现营业收入23,247亿元，累计同比增长-2.1%，实现营业利润3,492亿元，累计同比增长-29.2%。医药企业今年以来收入基本与上年同期持平，而营业利润出现较大幅度下降，主要由于上年全国大规模接种新冠疫苗抬高同期利润基数。同时由于新冠疫情防控措施影响，院内诊疗人数出现下降，终端药品销售同样受到压制增速放缓。
- 从22H1院内药品销售数据来看，集采后的药品在院内端销售基本实现触底反弹，即使上半年在新冠疫情压制就诊人数的情况下，不少重磅品种同比2021年同期依旧实现了两位数的增长。我们判断前几批次集采降价对于药企销售额的压制影响基本出清。而从近期江西IVD联盟集采、福建电生理联盟集采等集采规则来看，集采降价入围规则相较此前已有所放宽。
- 重磅产品将是未来创新药行业最大的驱动力，我们认为当前创新药板块已经从“量变”进入到“质变”的关键阶段，数十家创新药企业此前在2020年，2021年获批的新品有望在未来帮助一批Biotech公司扭亏为盈。而医药生物板块在底部估值区间仍具极高的投资配置价值，推荐关注创新药板块，建议关注：恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、盟科药业、泽璟制药。
- 风险提示：新冠疫情风险、新冠产业业务订单的可持续性、集采风险、新药研发风险、新药审批不确定性风险

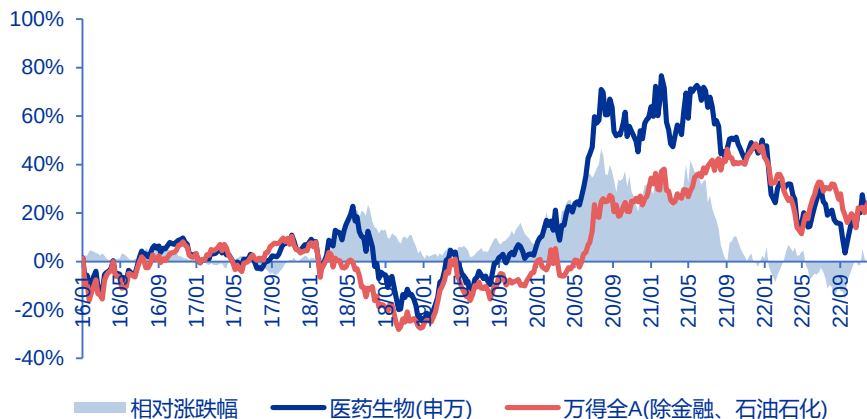
主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

1.1 行业整体行情复盘

- 截止至12月12日，今年以来申万医药生物指数累计涨跌幅为-15.6%，在31个申万一级行业中排名第16位，同期万得全A（除金融石油石化）累计涨跌幅为-15.9%，医药生物相对大盘涨跌幅为0.4%。
- 年初至2月份，医药生物板块基本延续上年持续调整走势；
 - 3月以来，受国内疫情管控以及新冠药物研发推进影响，CXO等板块走强抬升整体板块估值；
 - 上海新冠静态管理结束以后，全国对于新冠防控管制较年初趋严，影响医院入院诊疗人数增长以及院内药物销售增长，行业整体向下；
 - 9月末，受央行贴息贷款政策、江西IVD集采以及福建电生理耗材集采等多项政策事件驱动，叠加市场对于后续新冠管制政策预期变化，新冠诊疗、中成药等板块持续走强，医药生物板块与大盘整体涨跌幅差距大幅收窄。

2016年以来医药生物与大盘累计涨跌幅对比



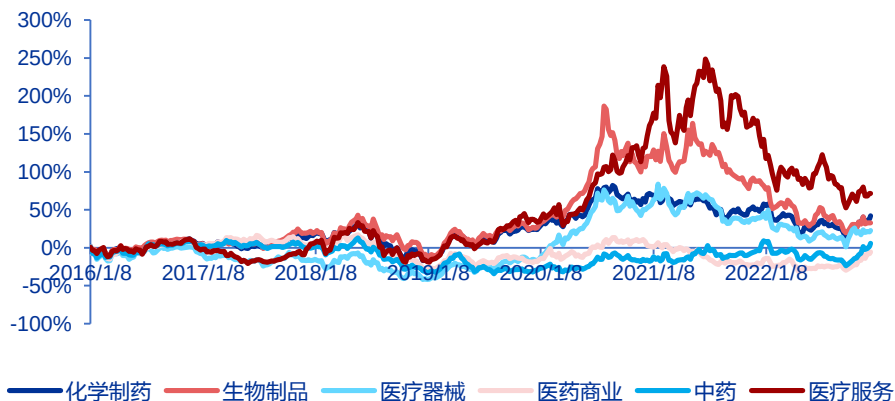
今年以来医药生物与大盘累计涨跌幅对比



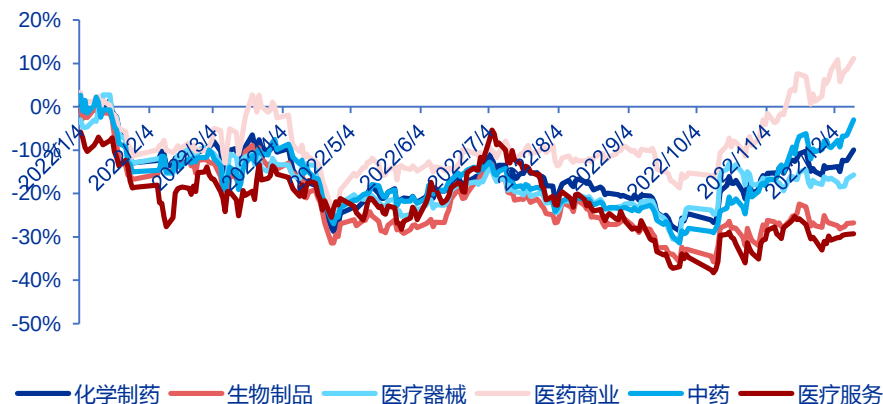
1.2 细分板块行情复盘

- 截止至12月12日，申万医药生物分类下，6个二级行业的累计涨跌幅情况如下：
医药商业（11.1%）>中药（-3.0%）>化学制药（-10.0%）>医疗器械（-15.7%）>生物制品（-26.8%）>医疗服务（-29.3%）。
- 医药商业板块今年以来表现突出，期间凸显防御属性；
 - CXO板块因为年中新冠小分子药物代工订单的事件影响，涨幅一度超过商业板块，后续由于订单可持续性以及国内创新药融资额以及临床申报数量减少，板块出现较大调整，同属服务板块下的医院板块同样因多地新冠疫情管理措施导致入院就诊人数出现同比下降，拉低板块涨幅；
 - 中药板块受政策支持因素，在此轮板块内部轮动中收益，弹性明显。

2016年以来医药生物各子板块累计涨跌幅对比



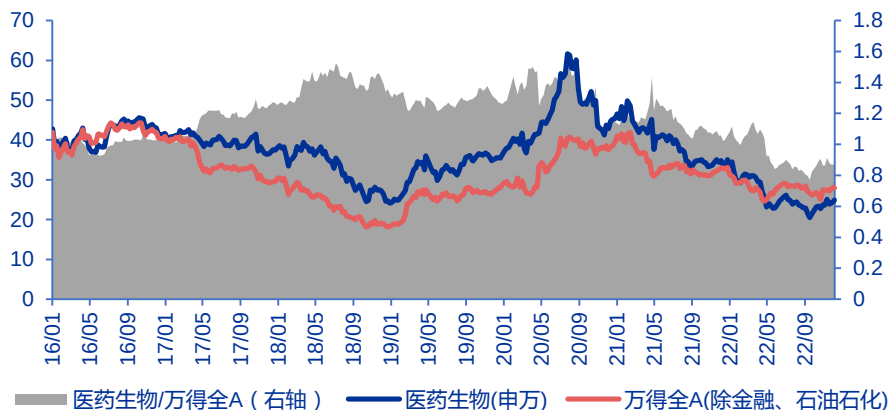
今年以来医药生物各子板块累计涨跌幅对比



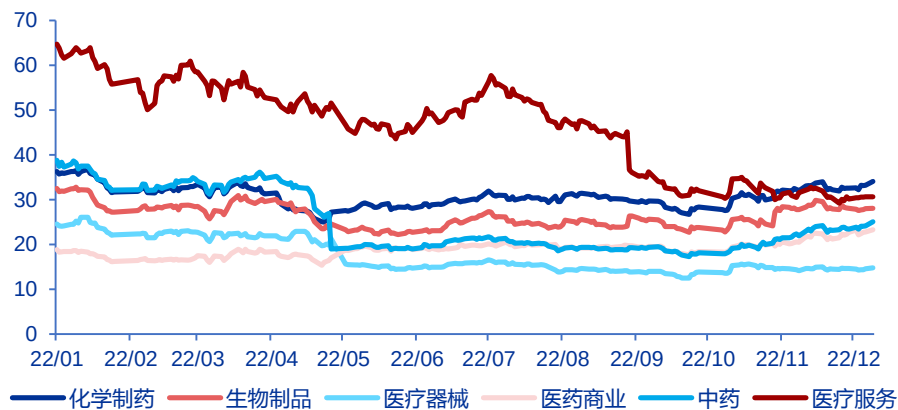
1.3 板块估值变化

- 截至12月12日，医药生物（申万）行业PE（TTM）估值为24.9x，同期万得全A（除金融、石油石化）为28.0x，自5月以来医药生物估值在2016年后首度低于大盘估值水平并持续至今。
 - 一方面九安医疗上半年因新冠抗原检测试剂出口订单收入确认带来高额利润拉高分母端，另一方面分子端医药板块指数在2021年7月触顶后开始深入调整，综合作用下医药板块相对大盘市盈率估值出现超额下降。
- 从细分行业估值水平来看，12月12日6个申万二级行业的PE（TTM）估值表现如下：化学制药（34.1x）、生物制品（28.1x）、医疗器械（14.8x）、医药商业（23.3x）、中药（25.0x）、医疗服务（30.7x）。
 - 医疗服务板块与其他板块之间的估值差距大幅收窄，一方面由于CXO持续中高速增长释放业绩，另一方面股价表现上医疗服务（医院与CXO）在今年以来深度回调，共同压低医疗服务行业估值水平。同期中药板块估值修复较为明显。

2016年以来医药生物与大盘PE（TTM）估值对比



今年6个子板块PE（TTM）估值变化对比



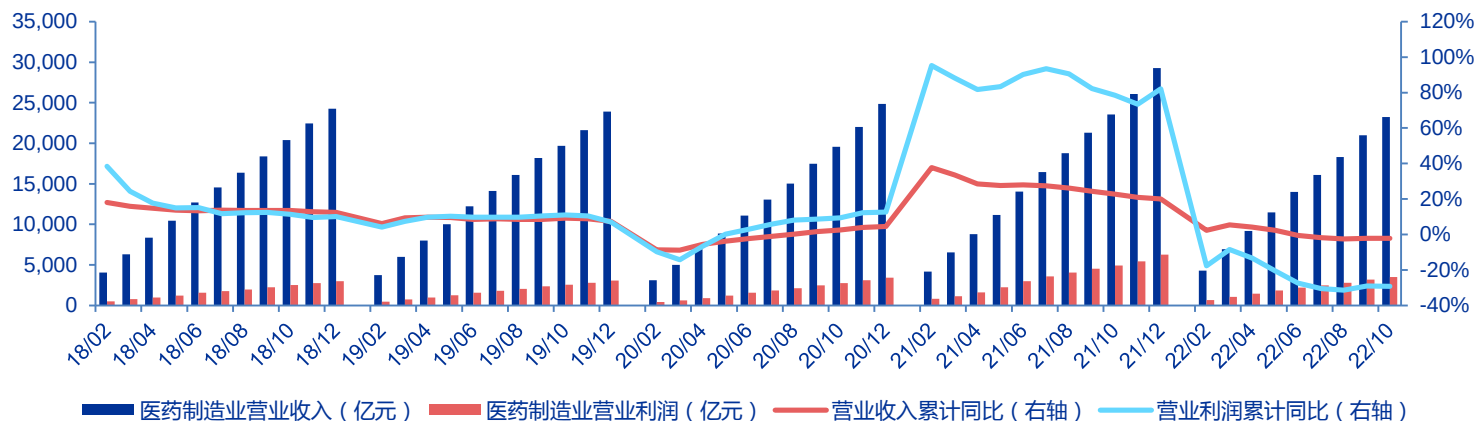
主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

2.1 医药制造业：上年疫苗接种垫高基数，营业利润负增长

- 截止至今年10月，全国规模以上医药制造业企业实现营业收入23,247亿元，累计同比增长-2.1%，较上月增速提升0.1个百分点，实现营业利润3,492亿元，累计同比增长-29.2%。
 - 医药企业今年以来收入基本与上年同期持平，而营业利润出现较大幅度下降，主要由于2021年全国大规模接种新冠疫苗抬高同期利润基数。
 - 从国内新冠疫苗的接种节奏看，疫苗接种主要集中在2021年，导致2021年规模以上医药制造业企业收入尤其是营业利润增速高于往年，高基数效应下2022年医药制造业收入有望于年末追平上年，但营业利润预计仍将呈现负增长。

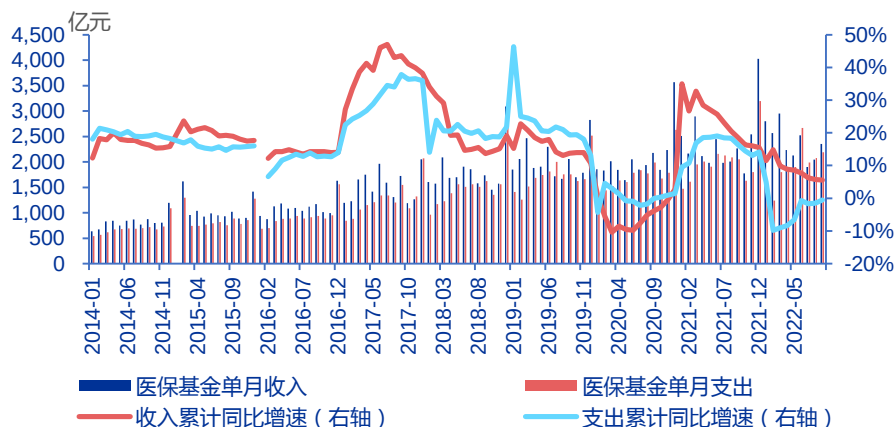
规模以上医药制造业企业营业收入与营业利润增速



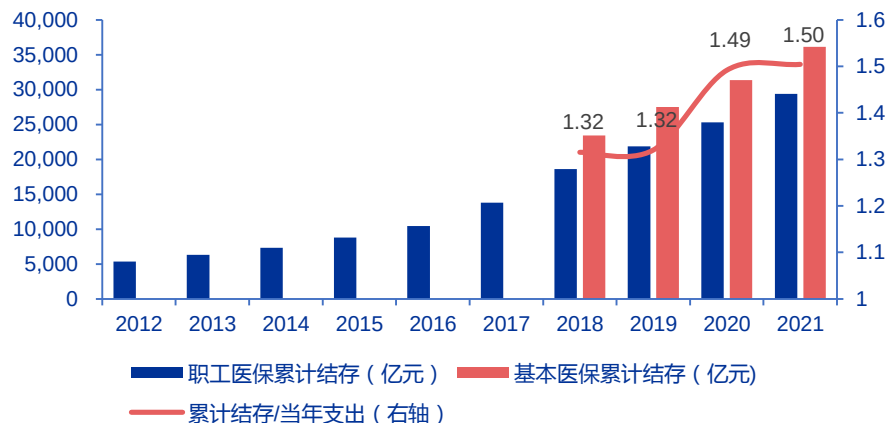
2.2 医保基金使用情况：收入增速持续高于支出

- 截止至今年9月，全国基本医保基金累计收入21,494亿元（yoy+5.5%），累计支出17,286亿元（yoy-0.5%）。
 - 因上年全国大规模新冠疫苗接种费用由财政与医保基金共同承担抬高上期支出基数，同时由于新冠防控引起入院诊疗人数减少，今年2月以来医保支出持续负增长，但降幅已经大幅收窄，预计至年末增速有望回正。
- 截止至2021年末，全国医保基金累计结余为36,122亿元，较上年增长4,748亿元，同比增长15.1%，累计结余/当年支出比例为1.5倍。

医保基金单月收支情况及增速对比



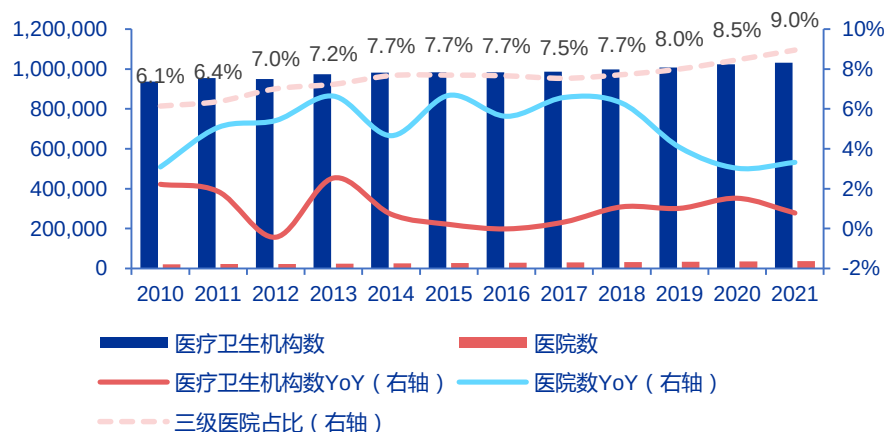
近年医保基金结存情况



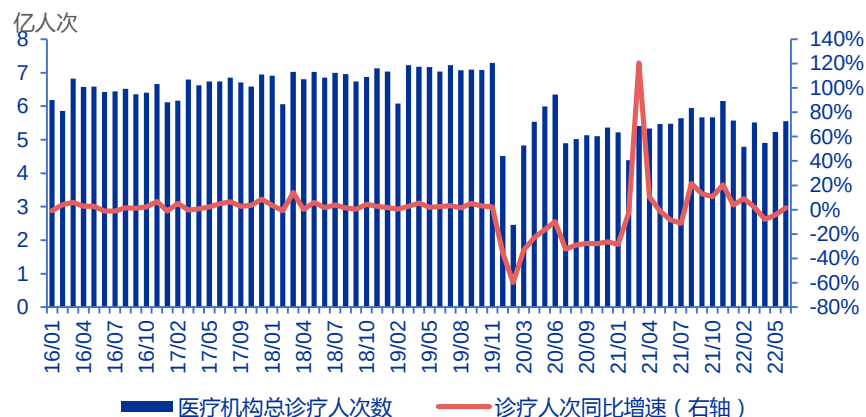
2.3 医院数量与诊疗：三级医院提速建设，诊疗人次再现下降

- 2021年末，国内医疗卫生机构总数约为103万个（yoy+0.8%），其中医院数量为36,570家（yoy+3.3%）。三级医院占比为9.0%，较上年末提升0.5pct，延续2017年以来三级医院数量占比稳步提升趋势。
- 截止至今年6月末，国内医疗机构总诊疗人次为31.56亿，累计同比增长0.9%，医院诊疗人次为19.62亿，累计同比持平，其中民营医院诊疗人次为3.16亿，累计同比增长4.2%。因为3月后全国多地进入静态管理管制，入院诊疗人数受此影响在4月出现2021年2月以来的首次负增长，至6月单月医疗机构诊疗人次同比增速回正。但就诊人次仍未恢复至疫情前水平。

医疗卫生机构数与医院建设增速



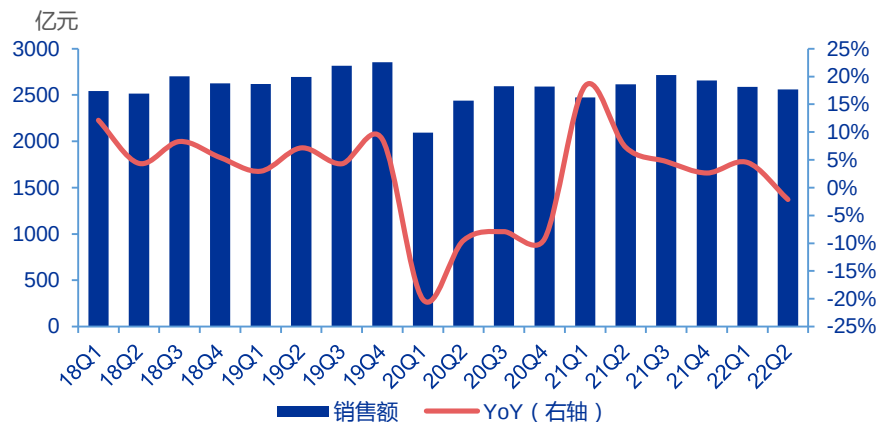
单月医疗机构诊疗人数及同比增速



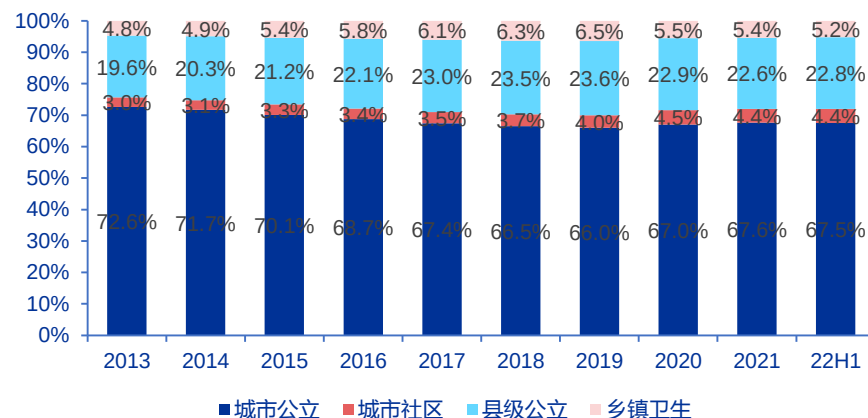
2.4 院内药品销售：疫情冲击院内化药与生物药增长趋缓

- 根据米内数据显示，2022H1医院端药品（化药+生物药）累计销售额为5,148亿元，同比增长1.1%，其中Q1和Q2的同比增速分别为4.5%和-2.1%。
 - 22H1同比20H1的终端销售增速为13.6%，其中22Q1和22Q2较2020年同期的增速分别为+23.7%和+5.0%，Q2受疫情管制措施影响较为明显。
- 22H1医院端，几大渠道的销售占比情况如下：城市公立医院（67.5%）、城市社区医院（4.4%）、县级公立医院（22.8%）、乡镇卫生院（5.2%）。
 - 从结构上看，2020年疫情爆发后城市公立医院的销售占比较此前略有提升。

国内院端化药与生物药销售额及增速



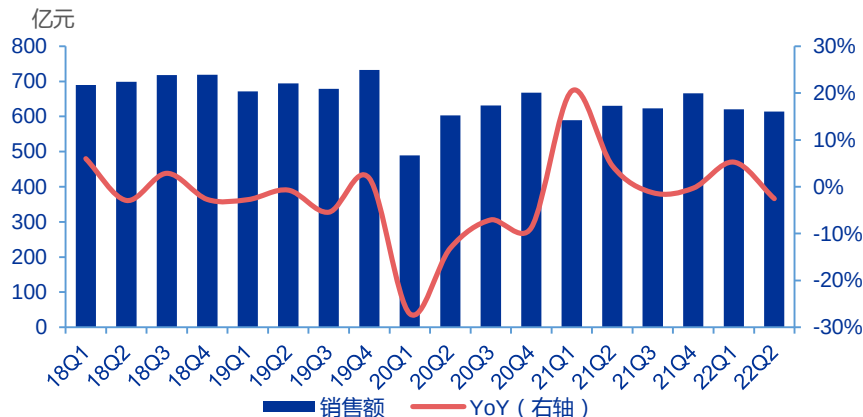
国内医院端化药与生物药渠道销售占比



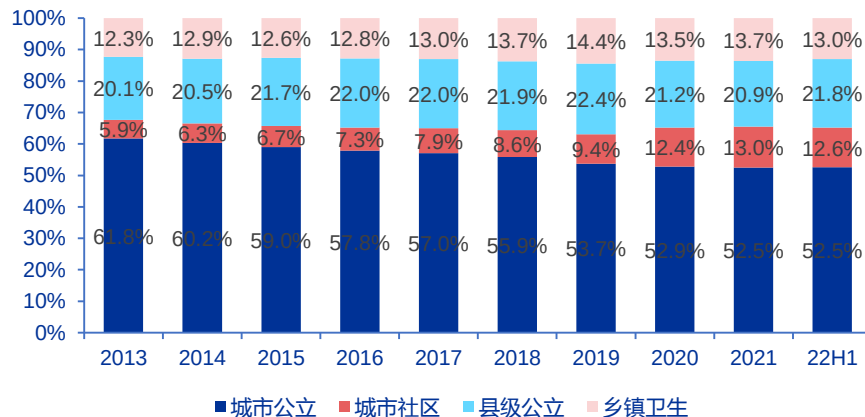
2.5 院内药品销售：中成药院内销售Q2呈负增长

- 根据米内数据显示，2022H1医院端中成药累计销售额为1,234亿元，同比增长1.2%，其中Q1和Q2的同比增速分别为5.3%和-2.5%。
 - 22H1同比20H1的终端销售增速为13.0%，其中22Q1和22Q2较2020年同期的增速为26.8%和1.8%。
- 22H1医院端，几大渠道的中成药销售占比情况如下：城市公立医院（52.5%）、城市社区医院（12.6%）、县级公立医院（21.8%）、乡镇卫生院（13.0%）。
 - 城市公立医院销售占比持续下降，由2019年的53.7%下降至22H1的52.5%。

国内院中成药销售额及增速



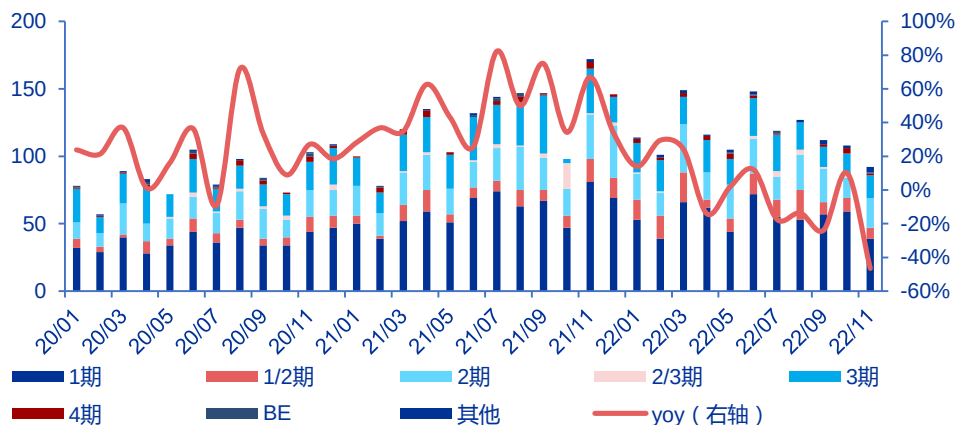
国内医院端中成药渠道销售占比



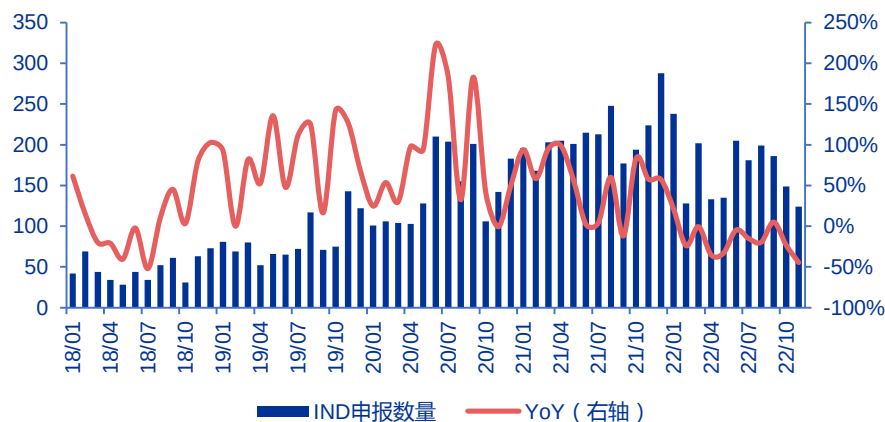
2.6 创新药临床申报：数量下滑，“内卷”改善

- 根据Insight CDE临床数据显示，截止至2022年11月化药新药与生物制品新药CDE公示临床共1,291项，累计同比下降6.2%
 - 自2021年7月创新药临床数量单月增速创下82%的记录以来，后续临床数增速出现持续性下降，至2022年4月单月临床数量增速首次呈现负增长，至11月单月增速进一步下降至-46.5%，创下近年以来的最低增速。
- 随着CDE对创新药的审评要求趋严，创新药行业的过度同质化竞争局面有望持续改善。

化药新药与生物制品新药CDE临床公示数量变化



国内创新药临床申报数量



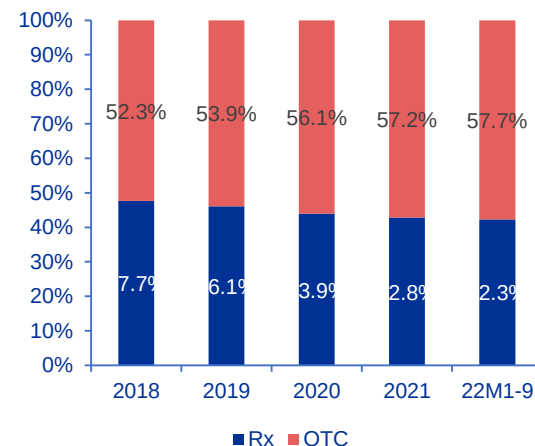
2.7 药店零售：生物制品与医疗器械增长表现突出

- 根据中康CMH统计，截止至今年9月国内零售药店总销售额为3,729亿元，累计同比增长3.4%，其中9月单月增速为1.0%。
- 从销售结构来看，1-9月药品市场份额占比78.9%，销售额累计同比增长3.8%，快于全国零售药店整体表现。化学药、中成药、生物制品均有所增长，其中化学药及生物制品增速较快。
- 1-9月非药市场增长缓慢，整体累计同比增速为1.9%，但医疗器械增速较快，为5.5%，而保健品及健康食品9月份单月同比较上年出现双位数下滑。

全国零售药店-药品及非药品增长率

	销售额占比 (YTD 22M9)	销售额累计同比 (YTD 22M9)
药品市场	78.9%	3.8%
化学药	42.8%	4.9%
中成药	30.7%	1.9%
生物制品	5.4%	6.1%
非药品市场	21.1%	1.9%
医疗器械	6.6%	5.5%
中药饮片	6.1%	3.6%
保健品及健康食品	5.6%	-1.4%
其他 (消字号/日常用品/化妆品等)	2.8%	-3.1%

处方药销售占比持续提升



主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

3.1 历次集采结果以及降幅

- 在六批七轮集采中，前五批六轮都是化学药集采。从第一批“4+7带量采购”到第五批带量采购，一共覆盖218个品种，第六批集采首次纳入16个生物药品种，6批药品共涉及金额占公立医疗机构年药品采购总额的30%。
- 截至2021年底，国家组织药品和高值医用耗材集采已累计节约费用2,600亿元。
- 第七批集采首次将化药集采的平均降幅提升至48%，与生物药集采降幅相近，低于此前历次化药集采。集采已于11月在各地陆续执行。

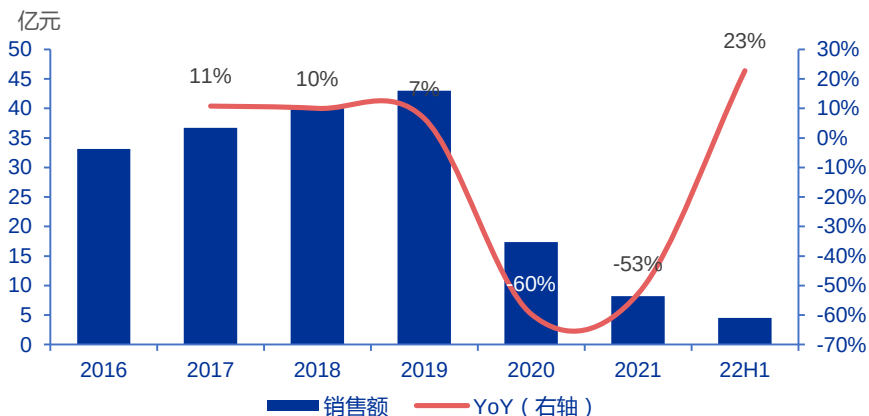
历次药品集采结果

集采批次	集采文件发布时间	开标时间	集采品种数量	中选品种数量	落标品种	平均降幅	最高降幅
4+7	2018年11月15日	2018年12月17日	31	25	6	52%	96%
4+7扩围	2019年9月1日	2019年9月25日	25	25	0	59%	-
第二批	2019年12月29日	2020年1月17日	33	32	1	53%	93%
第三批	2020年7月29日	2020年8月20日	56	55	1	53%	95%
第四批	2021年1月15日	2021年2月3日	45	45	0	52%	96%
第五批	2021年6月2日	2021年6月23日	62	61	1	56%	98%
第六批（胰岛素专项）	2021年11月5日	2021年11月26日	16	16	-	48%	72%
第七批	2022年6月20日	2022年7月12日	61	60	1	48%	98%

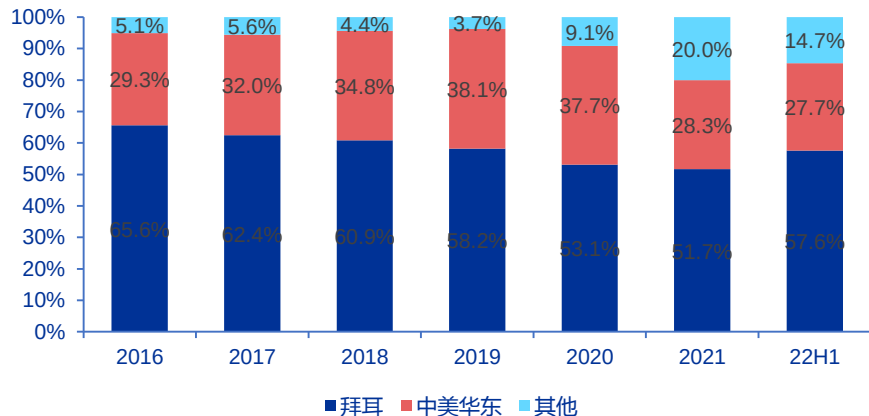
3.2.1 集采品种分析：阿卡波糖

- **集采情况**：阿卡波糖原研厂家为拜耳，药品被纳入第二批国家集采，拜耳原研产品中标，报价较最高有效申报价降幅为78%，华东医药并未中标。
- **集采后发展**：集采失标之后，华东医药在未集采市场（基层医院，私立医院和OTC市场）继续发力。潜力品种吡格列酮二甲双胍片及吡哌布芬片销售收入在2020H1均实现翻番。同时华东医药开始向医美领域拓展。
- **市场格局**：据米内数据显示，22H1阿卡波糖院内销售额为4.5亿元，同比增长23%，其中拜耳、华东医药份额占比分别为57.6%、27.7%。华东医药的市场份额在2021年后保持在28%左右，基本稳定。

阿卡波糖城市公立医院销售额



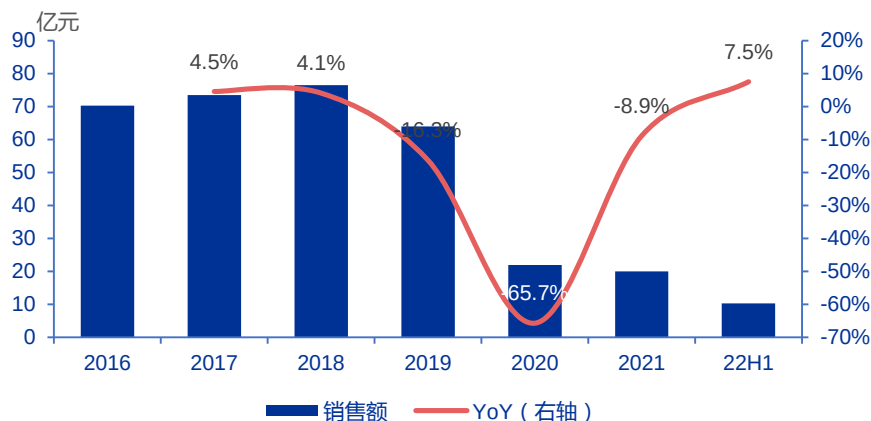
阿卡波糖城市公立医院竞争格局



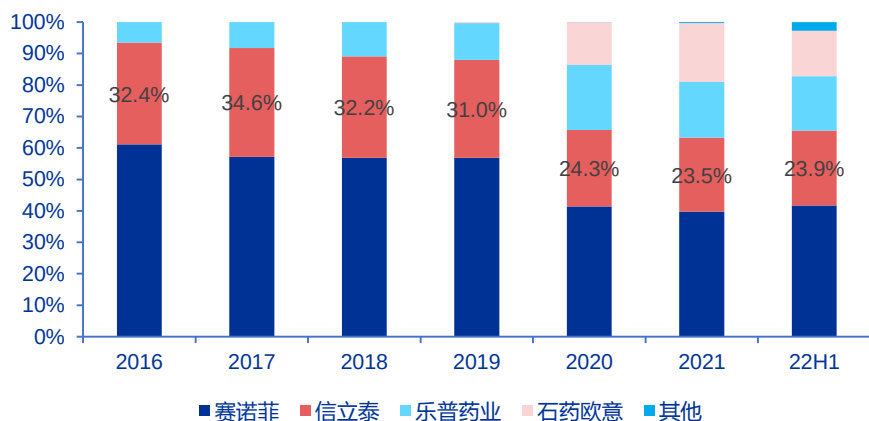
3.2.2 集采品种分析：氯吡格雷

- **集采情况**：氯吡格雷原研药由赛诺菲和BMS联合研发，2018年硫酸氢氯吡格雷片被纳入第一批集采，信立泰中标在首轮“4+7”中价格降幅为58%，但未在扩围中中标。
- **集采后发展**：信立泰旗下绝大多部分仿制药已被纳入后续集采品种，公司后续集中于创新药和器械发力。
- **市场格局**：据米内网数据显示，22H1氯吡格雷在医院端销售额为10.2亿元，同比增长7.5%，其中赛诺菲、信立泰与乐普的市场份额分别为41.7%、23.9%、17.2%。赛诺菲的市场份额从2019年的56.9%下降至2020年的41.4%后基本保持稳定，信立泰市场份额也维持在24%左右。

氯吡格雷城市公立医院销售额



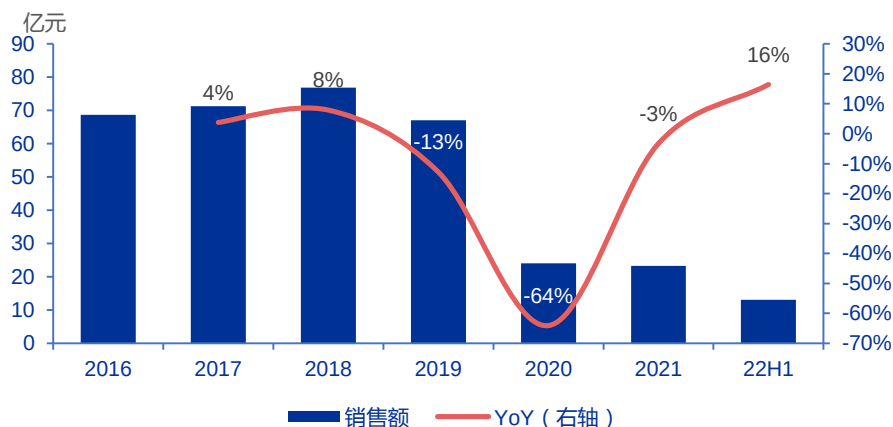
氯吡格雷城市公立医院竞争格局



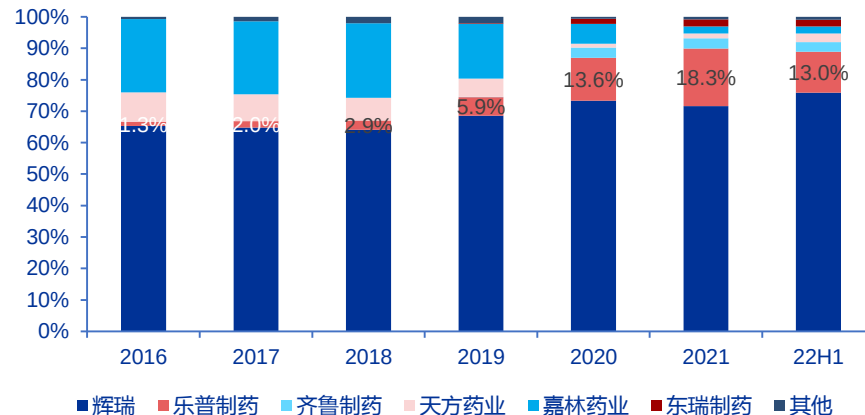
3.2.3 集采品种分析：阿托伐他汀

- **集采情况**：阿托伐原研厂家为辉瑞公司，药物被纳入首批4+7集采当中。集采中，首轮中标的是北京嘉林，价格降幅为83%；扩围中标的是齐鲁、乐普、兴安，报价较4+7中标价分别下降78%、43%、77%。
- **市场格局**：根据米内网数据显示，22H1阿托伐他汀在城市公立医院销售额为13亿元，其中原研辉瑞、乐普、齐鲁的市场份额分别为75.9%、13.0%和3.1%，较2021年的市场格局相比，乐普的市场份额有所下降（-5.3pct），原研辉瑞的市场份额进一步提升。

阿托伐他汀城市公立医院销售额



阿托伐他汀城市公立医院竞争格局



3.3 前五批集采对于相关公司的负面影响基本消化

- 从22H1的销售数据来看，集采后的药品在院内端销售基本已经触底反弹，即使上半年在新冠疫情压制就诊人数的情况下，不少重磅品种同比2021年同期依旧实现了两位数的增长。我们判断前几批次集采降价对于药企销售额的压制影响基本出清。
- **市场份额趋于稳定**：集采落地实施1-2年后，重磅品种的市场格局基本保持稳定，原研仍然相对较多的市场份额，部分在集采中中标获得区域报量的企业也能脱颖而出（如乐普），但即使集采未中选，如信立泰和华东医药在院内市场份额在经过调整后，亦趋向稳定，未出现持续性萎缩。
- **集采落选后的战略转型**：如信立泰和华东医药，在集采遇挫后并没有“坐以待毙”，而是不约而同的选择了转向创新药/器械甚至于医美领域的研发。

3.4.1 集采政策趋缓：冠脉支架续标——“量价齐升”

- **11月29日，国家组织高值医用耗材联合采购办公室发布《国家组织冠脉支架集中带量采购协议期满后接续采购拟中选结果公示》，共有14个产品拟中选，中选产品中位价约为832元，相较上一轮中选产品700元的中位价格，同比增长19%。**
 - 本次续标共涉及美敦力、上海微创等国内外10家企业，企业中选率达91%。
 - 2020年首次冠脉支架集采共有10 个产品中选，中选产品价格区间为469-798元，而本轮冠脉支架续标共有14个产品拟中选，中选产品价格区间为730-848元（含伴随服务价格50元），其中微创医疗拟中标价730-848元，中标产品提价约24%；乐普医疗中标价848元，提价约31%；吉威医疗中标价824-845元，提价约76%。
 - 与上一轮集采相比，本次接续采购参加的医疗机构增加40%，支架采购量增加30%，中选企业增加2家，中选产品增加4个。

3.4.2 集采政策趋缓：江西IVD生化集采—40%降幅保中标

- 11月14日，江西省医药采购服务平台正式发布公告称，将与河北省、陕西省等22地联合开展肝功生化类检测试剂省际联盟集采，涉及白蛋白等26款临床常用产品，采购周期为2年（可视情况延长1年）。
 - 肝功生化是国家医保局今年4月重点部署的三大省级专项集采之一，由江西省负责牵头。
- 拟中选规则显示，首轮竞价未能中选的A组企业，若承诺向全联盟供应产品，且申报价格不高于最高有效申报价格0.6倍的，可增补为“拟中选企业”，不受中选企业数量限制。
- 分组方面，竞价分组分A、B两组，按医疗机构意向采购量从多到少依次排序，承诺满足全联盟地区全部采购需求且全联盟或任一联盟省份意向采购量前70%的企业进入A组，其他企业进入B组。

- **10月14日，福建省药械联合采购中心发布《心脏介入电生理类医用耗材省际联盟集中带量采购公告（第1号）》。联盟成员包括福建、河北、浙江、广东等在内的27省（区、市）。而电生理类耗材也是首次纳入省级带量采购名单。**
 - （品规介绍）
 - 此次纳入集采的电生理产品基本上属于通用型的耗材，国产化程度较高、替代性较强。
 - 采购模式分为组套采购模式、单件采购模式、配套采购模式，其中组套采购模式、单件采购模式两种明确了具体中选规则并设定了“保底价”，（1）组套采购下，基于最高限价同分组中降幅 $\geq 30\%$ 的组套获得拟中选资格。**电生理组套产品降价30%，可获基础采购量的40%，降价大于50%，可获得80%的采购份额。较此前高值耗材集采更为温和。**（2）单件采购采购价格下，基于最高限价同分组中降幅 $\geq 50\%$ ，可获得拟中选资格。
- **根据微电生理招股书，2020年国产电生理医疗器械市场份额仅为9.6%，而国产企业有望借助后续集采加速入院，实现份额提升。**

- **9月9日，国家医保局发布《关于开展口腔种植医疗服务收费和耗材价格专项治理的通知》，要求开展全面覆盖公立和民营医疗机构的口腔种植价格专项治理工作。**
 - 此前8月医保局发布相关通知征求意见稿。
 - 通知规定种植体植入费、牙冠置入费、植骨手术费等口腔种植项目实行政府指导价管理的地区，医疗保障部门在规范价格项目的同时，重新制定公布政府指导价。通知指出，“*目前三级公立医疗机构完成全流程种植，医疗服务价格整体普遍高于4500元每颗的地区，应采取针对性措施，导入至整体不超过4500元每颗的新区间，三级以下公立医疗机构的调控目标参照当地医疗服务分级定价的政策相应递减。*” **4500元每颗为医疗服务价格的全流程调控目标，并不包括种植体和牙冠等耗材。**
 - ✓ 在种植牙收费中，耗材占了比例的三分之一，医疗服务价等占了三分之二左右。根据国家医保局近期全国范围内登记调查的初步结果显示，以各省份公立医疗机构单颗常规种植为例，医疗服务部分的平均费用超过6000元，一些省市费用超过9000元，已经成为种牙价格过高的重要原因之一。
 - 通知提出**对种植牙耗材以集中采购为主要抓手**，竞争形成透明合理的价格。明确由四川省医疗保障局牵头组建种植牙耗材省际采购联盟，各省份均应参加。
- **11月17日，四川省药械招标采购服务中心发布《川药招〔2021〕258号关于开展部分口腔类高值医用耗材产品信息采集工作的通知》，拟自11月18日起分阶段开展相关产品信息申报工作。**

主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

4.1 2022年医保目录调整启动

- **6月29日，国家医疗保障局公布《2022年国家基本医疗保险、工伤保险和生育保险药品目录调整工作方案》及相关文件，第五轮国家医保药品目录调整工作正式启动。**
 - 本次目录调整在申报范围上进行了优化：向罕见病患者、儿童等特殊人群适当倾斜。对罕见病用药的申报条件**没有设置“2017年1月1日后批准上市”的时间限制**，同时增加了**纳入国家鼓励仿制药品目录、鼓励研发申报儿童药品清单的药品可以申报今年医保目录**。
 - 非独家药品准入时同步确定支付标准
 - ✓ 专家测算确定医保支付意愿，然后企业自主报价，只要有一家企业参与且报价低于医保支付意愿，该通用名就可纳入目录，并以最低报价作为该通用名的支付标准。
 - 续约规则方面，将非独家药品（无论协议是否到期），以及已经历过两个协议期（4年）但支付标准和支付范围均无变化的独家药品纳入常规目录管理；对今年调整医保支付范围但对基金影响预算不大（未超1倍）的药品也可以简易续约。
- **9月18日，国家医保局公示《2020年国家医保药品目录调整通过形式审查的申报药品名单》。**
- **12月6日，国家医保局发布公告，2022年国家医保药品目录现场谈判延期开展。具体时间确定后，将提前一周左右通知各谈判主体。**

- **7月13日，北京市医保局印发《CHS-DRG 付费新药新技术除外支付管理办法的通知（试行）》，**
 - 文件对于药品和医疗器械，同时满足以下条件的药品及医疗器械可由企业向北京市医保中心申报：
 - ✓ 三年内(指含申报年及之前的两个自然年，下同)经药监部门批准上市的新通用名药品/医疗器械；三年内因增加功能主治或适应症发生重大变化的药品；三年内新纳入国家医保药品目录的药品；三年内由于价格调整新增的可另行收费的医疗器械；
 - ✓ 取得国家医疗保障局医保药品分类与代码/医保医用耗材分类与代码；
 - ✓ 符合相关价格政策规定；
 - ✓ 临床效果较传统药品/医疗器械有较大提升；
 - ✓ 对DRG 病组支付标准有较大影响；
 - ✓ 全市累计基本医疗保险参保人员病例达到50例以上，罕见病不受例数限制。
- **此次北京市医保局对于创新药品及器械的支付政策管理规定，为具备临床价值的创新药物/器械企业带来了更好的商业支付环境和研发环境，使得创新药品/器械免于DRG支付政策的影响，致使在上市后终端放量受到影响。**

主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

5.1 加强老年人新冠病毒疫苗接种

- **11月29日，国务院联防联控机制综合组印发《加强老年人新冠病毒疫苗接种工作方案》，要求进一步加快推进老年人新冠病毒疫苗接种工作，加快提升80岁以上人群接种率，继续提高60-79岁人群接种率。**
 - 截至2022年11月28日，全国累计报告接种新冠病毒疫苗34.43亿剂次，60岁以上老年人接种的覆盖人数为2.39亿人，完成全程接种2.28亿人，完成加强免疫接种1.82亿人，覆盖人数、全程接种人数和加强免疫人数分别占老年人口的90.68%、86.42%和68.75%，其中**80岁以上老年接种的覆盖人数为0.27亿人，完成全程接种0.24亿人，完成加强免疫接种0.14亿人，覆盖人数、全程接种人数和加强免疫人数分别占80岁以上人口的76.6%、65.8%和40.4%**。60岁以上老年人接种率仍有提升空间，特别是加强免疫。
 - 所有已获批开展加强免疫接种的疫苗及组合均可用于第一剂次加强免疫，根据国内外真实世界研究和临床试验数据，结合我国老年人群疫苗接种实际情况，第一剂次加强免疫与全程接种时间间隔调整为3个月以上。除已获批产品外，多款针对Omicron等变异株的疫苗正处于临床阶段，包括灭活、重组蛋白、mRNA等多条路线，其有效性数据值得期待。
- **12月14日，国家卫健委印发新冠病毒疫苗第二剂次加强免疫接种实施方案的通知，提出“现阶段，可在第一剂次加强免疫接种基础上，在感染高风险人群、60岁以上老年人群、具有较严重基础性疾病人群和免疫力低下人群中开展第二剂次加强免疫接种。”**

5.2 新冠疫情防控措施再优化

- **12月7日，国务院联防联控机制综合组发布《关于进一步优化落实新冠肺炎疫情防控措施的通知》。为更加科学精准防控，切实解决防控工作中存在的突出问题，文件针对性地提出了十项措施，其中包括：**
 - 科学精准划分风险区域，按楼栋、单元、楼层、住户划定高风险区；
 - 进一步优化核酸检测，不按行政区域开展全员核酸检测，进一步缩小核酸检测范围、减少频次，**除养老院等特殊场所外，不要求提供核酸检测阴性证明，不查验健康码；**
 - 优化调整隔离方式，感染者要科学分类收治，**具备居家隔离条件的无症状感染者和轻型病例一般采取居家隔离，也可自愿选择集中隔离收治；**
 - 落实高风险区“快封快解”；
 - **保障群众基本购药需求**，各地药店要正常运营，不得随意关停。不得限制群众线上线下购买退热、止咳、抗病毒、治感冒等非处方药物；
 - **加快推进老年人新冠病毒疫苗接种**，聚焦提高60-79岁人群接种率、加快提升80岁及以上人群接种率；
 - 加强重点人群健康情况摸底及分类管理；
 - 保障社会正常运转和基本医疗服务；
 - 强化涉疫安全保障；
 - 进一步优化学校疫情防控工作。

5.3 居家治疗指南发布，新冠互联网医疗启动

- 12月7日，国务院联防联控机制综合组发布《新冠病毒感染者居家治疗指南》，适用于无症状及轻症感染者以及基础疾病处于稳定期无需住院的感染者。
 - 对于居家治疗人员症状明显好转或无明显症状，自测抗原阴性并且连续两次新冠病毒核酸检测Ct值 ≥ 35 （两次检测间隔大于24小时），可结束居家治疗，恢复正常生活和外出。
- 12月12日，国务院联防联控机制综合组发布《关于做好新冠肺炎互联网医疗服务的通知》，指出医疗机构（包括互联网医院、开展互联网诊疗服务的医疗机构）可以通过互联网诊疗平台，依据最新版新型冠状病毒肺炎诊疗方案有关要求，为出现新冠肺炎相关症状的患者，**在线开具治疗新冠肺炎相关症状的处方**。

新冠病毒感染者居家治疗常用药参考表

症状	常用药物
发热	对乙酰氨基酚、布洛芬、阿司匹林、金花清感颗粒、连花清瘟颗粒/胶囊、宣肺败毒颗粒、清肺排毒颗粒、疏风解毒胶囊等
咽干咽痛	地喹氯铵、六神丸、清咽滴丸、疏风解毒胶囊等
咳嗽咳痰	溴己新、氨溴索、愈创甘油醚、乙酰半胱氨酸等
干咳无痰	福尔可定、右美沙芬等
流鼻涕	氯苯那敏、氯雷他定、西替利嗪等
鼻塞	赛洛唑啉滴鼻剂等
恶心/呕吐	桂利嗪、藿香正气水/胶囊等

5.4 加速医疗基础设置建设，提升基层重症救治能力

- 12月11日，国务院联防联控机制综合组印发《依托县域医共体提升农村地区新冠肺炎医疗保障能力工作方案》，要求发挥县域医共体牵头的县级医院在农村地区医疗服务体系中的龙头作用，形成县、乡、村三级联动的医疗服务体系，提升农村地区重症救治能力。
- 县级医院要在12月底前实现以下目标：
 - 做好重症医疗资源准备，用于感染新冠病毒的各类重症患者治疗的综合ICU床位数量不少于本院实际开放床位总数的4%；
 - 做好重症医学专业相关医护人员准备。医院应当以综合ICU和其他专科ICU床位总数为基数，1张ICU床位配备1名医生和2.5-3名护士；
 - 加强缓冲病房建设；
 - 做好传染科建设。
- 12月9日，国务院联防联控机制在新闻发布会介绍中西医结合医疗服务保障有关情况，其中提到ICU床位建设目标：**三级医院综合ICU要达到床位总数4%的比例，再按照床位总数4%的比例改造可转换ICU床位（即8%总床位比例）**；方舱医院升级改造成亚定点医院，按照其床位10%的比例来改造监护床位；二级医院重症监护科和重症监护病房按照标准进行改造，作为三级医院重症资源的重要补充。

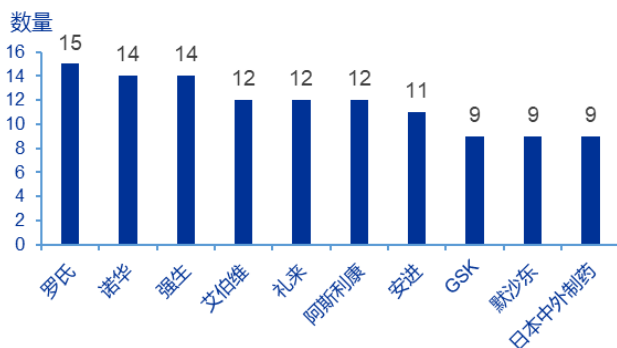
主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

6.1 重磅产品是创新药产业最大的催化剂

- **重磅产品是创新药行业最大的驱动力。**上一轮创新药行情是伴随着PD-1肿瘤免疫疗法的兴起，恒瑞医药、百济神州、信达生物、君实生物等一批创药牛股诞生，也拉动整个创新药板块行情。
- **重磅炸弹药物是成为TOP级Big Pharma的标配。**2021年销售额超过10亿美金的重磅炸弹级药物有166个，合计销售额5,373亿美元，涉及近50家企业，多为全球制药巨头。销售额在50亿美元以上的超级重磅炸弹级药物有25个，合计销售额2,541亿美元。随着国内创新药企业尚处于发展初期，未来有望出现一批拥有重磅炸弹级的药物的企业。

拥有重磅炸弹级药物数量Top10企业



部分2021年全球销售TOP100医药产品情况

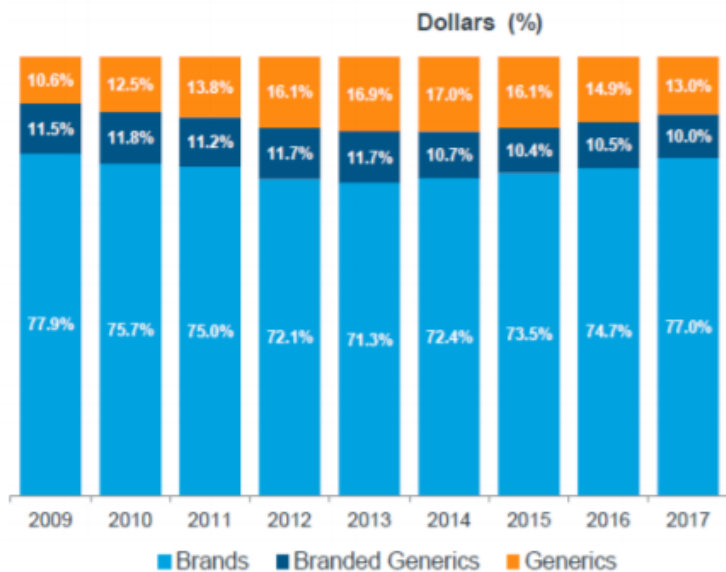
排名	产品名	靶点	适应症	2021年销售额 (亿美金)
1	Comirnaty	mRNA	Covid 19	403.41
3	Spikevax	mRNA	Covid 19	176.75
9	乌司奴单抗	IL-12/23	自身免疫疾病	91.34
14	度拉糖肽	GLP-1RA	2型糖尿病	64.72
15	度普利尤单抗	IL-4R	特应性皮炎	61.94
17	达雷妥尤单抗	CD38	多发性骨髓瘤/AL淀粉样变性	60.23
22	Ocrevus	CD20	多发性硬化症	55.55
23	哌柏西利	CDK4/6	乳腺癌	54.37
24	司美格鲁肽	GLP-1	糖尿病/肥胖	53.59
28	司库奇尤单抗	IL-17A	自身免疫疾病	47.18
29	维得利珠单抗	$\alpha 4\beta 7$	溃疡性肠炎、克罗恩病	46.05
33	托珠单抗	IL-6	类风湿关节炎、细胞因子释放综合征等	39.14
34	芦可替尼	JAK	骨髓纤维化、移植后宿主病等	37.3
37	奥马珠单抗	IgE	哮喘/COPD、荨麻疹	35.62
38	沙库巴曲缬沙坦	ACEI/ARB	心衰	35.48
43	艾美赛珠单抗	凝血因子IXa/XII抗	血友病	33.21
45	地舒单抗	RANKL	骨质疏松	32.48
51	瑞莎珠单抗	IL-23	自身免疫病	29.39
66	Shingrix	疫苗	带状疱疹疫苗	23.66
70	阿普斯特	PDE4	斑块状银屑病、银屑病关节炎、白塞氏病	22.49
73	依奇珠单抗	IL-17A	斑块状银屑病	22.13
74	恩美曲妥单抗	HER2 ADC	HER2+乳腺癌	21.78
77	古赛奇尤单抗	IL-23	自身免疫病	21.27
80	地舒单抗	RANKL	实体瘤骨转移，骨肉瘤	20.64
92	氟替卡松/沙美特罗	复方药	哮喘/COPD	18.66
96	维奈克拉	BCL2	CLL、急性粒细胞白血病	18.2

备注：我们梳理了2021年全球TOP100药物里，国内没有或者尚处于放量初期的重磅炸弹级药物，我们认为未来上述药物在国内的市场前景非常可观。

6.2 对标美国市场，国内创新药市场份额有望突破50%以上

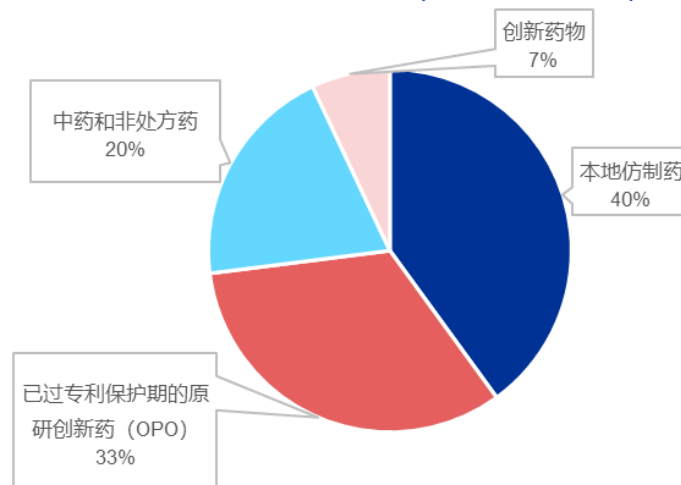
- 2021年全球医药市场规模达到13,934亿美元，其中创新药市场规模为9,616亿美元，仿制药市场预计为4,318亿美元，创新药市场占比为69%；美国作为全球医药市场的主要参与者，市场创新药的市场占比一直保持在70%-80%左右，医药市场的发展主要依赖创新药驱动。
- 根据沙利文的统计，2019年国内创新药占比仅有7%，远远低于美国市场，中国药品终端总销售额超过20,000亿元，对标美国市场，未来创新药占比有望超过50%，终端体量预计将超过1万亿，相较目前的市场规模有10倍提升空间。

美国医药市场情况



2019年中国医药市场结构

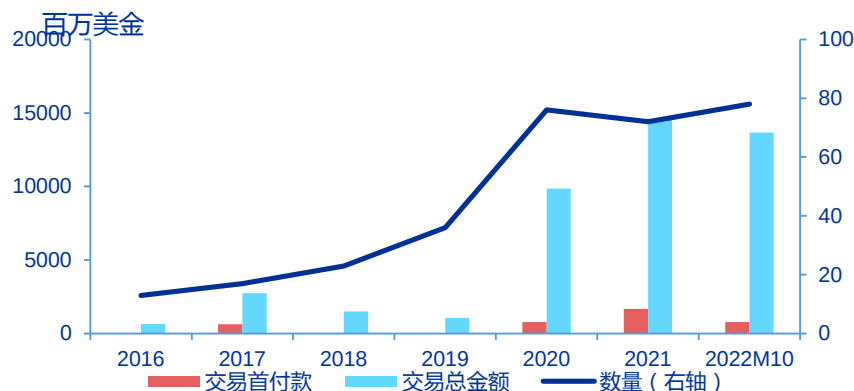
2019年中国医药市场结构 (总市值2470亿美金)



6.3 国内良性的创新生态开始形成

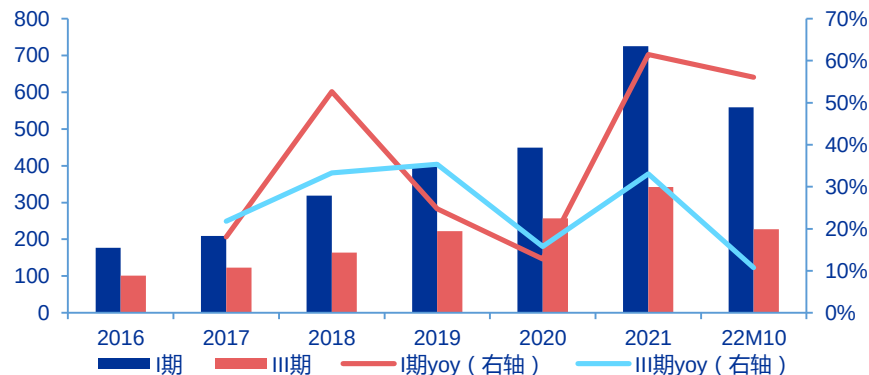
- **积极参与全球创新。**创新药价值最大化要求参与全球化，尤其是进入美国市场，小的 Biotech 可以通过 license out 的方式加快进入全球市场，2020 年开始，国内企业 license out 交易呈现爆发式增长；有资金实力的企业则采取自主开展临床试验自主申报的方式来参与创新药全球化。
- **创新药价值回归：以临床价值为导向进行开发。**2021 年 11 月 19 日，《以临床价值为导向的抗肿瘤药物临床研发指导原则》，新药研发应以为患者提供更优（更有效、更安全或更便利等）的治疗选择作为更高目标。创新门槛的提升带来的连锁反应，包括管线优化、创新升级以及产品竞争格局优化。

国内药企 license-out 项目情况



转让方所在地：中国；受让方所在地：海外；首付款和交易总金额为披露的金额加总

国内 I 和 III 期临床开展数量

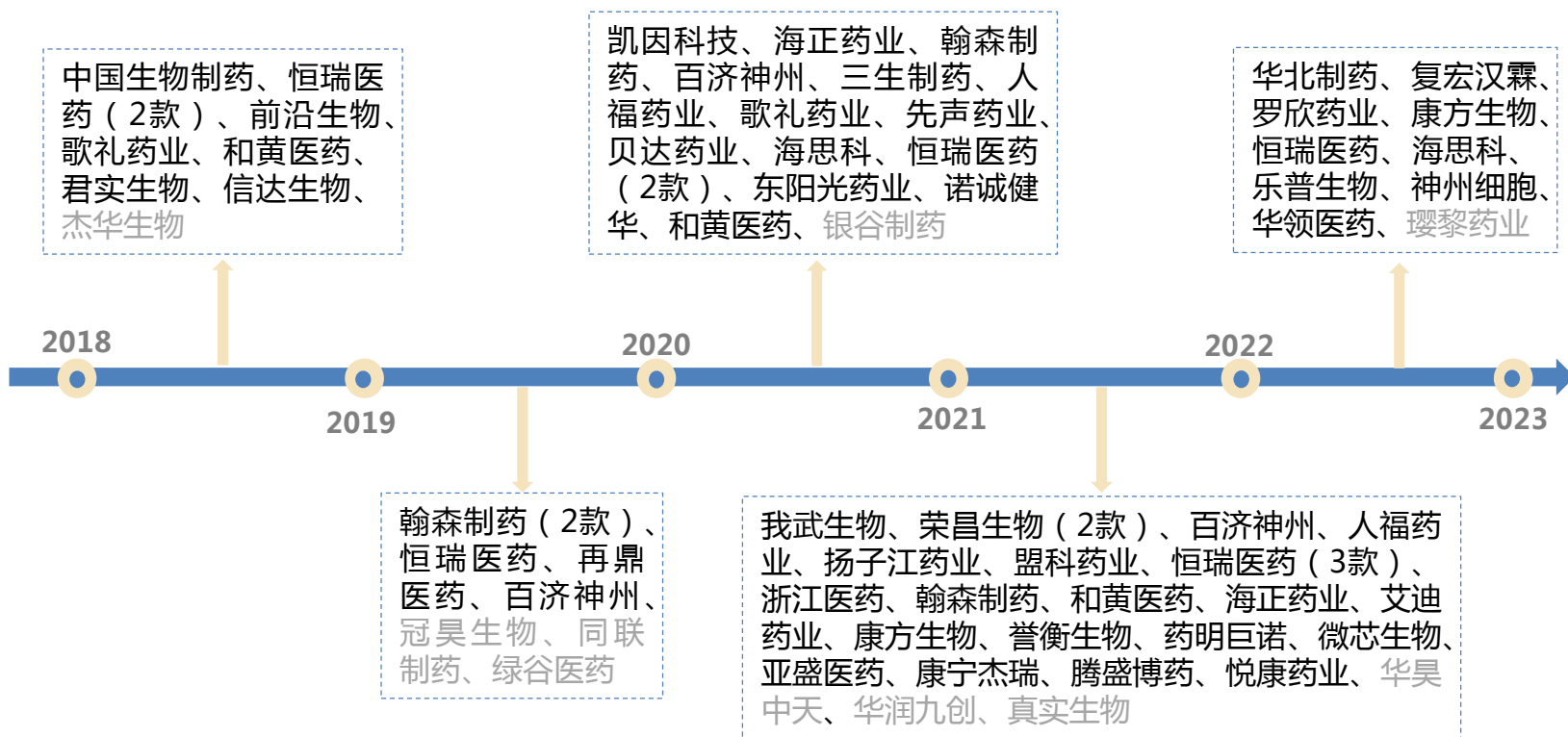


备注：2022 年 M10 同比增速选择与 2020 年 M10 进行比较，较少由 2021 年国内开展的较多新冠疫苗相关临床的数据扰动

6.4 预计未来2-3年将有一批Biotech开始实现盈利

- 2015年国家出台了一系列鼓励创新药行业的政策，2018年行业开始进入收获期，在经历7-8年的商业化放量后，预计一批Biotech将开始扭亏为盈，实现盈利，企业在研发、生产和销售层面也将进入良性循环。

2018年至今每年有新品种获批的企业情况



6.5.1 恒瑞医药——创新龙头，业绩拐点将至

■ 集采负面影响已基本消化

- 第五批集采恒瑞涉及金额在40-50亿左右，2021年10月份开始执行，2022年4季度预计第五批集采影响已基本消化完毕，后续受集采影响较小；

■ PD-1销售趋于稳定

- PD-1市场已经形成稳定的格局，恒瑞、百济、信达位于国产第一梯队，简易续约规则的出台，PD-1降价压力得到缓解；引导了企业合理降价，明晰了降幅预期

■ 创新品种不断兑现，创新药板块恢复快速增长趋势

- 公司管线丰富，研发效率高，管线已经进入收获期，未来3年每年至少有2-3个新产品获批上市，拉动创新药板块快速增长。

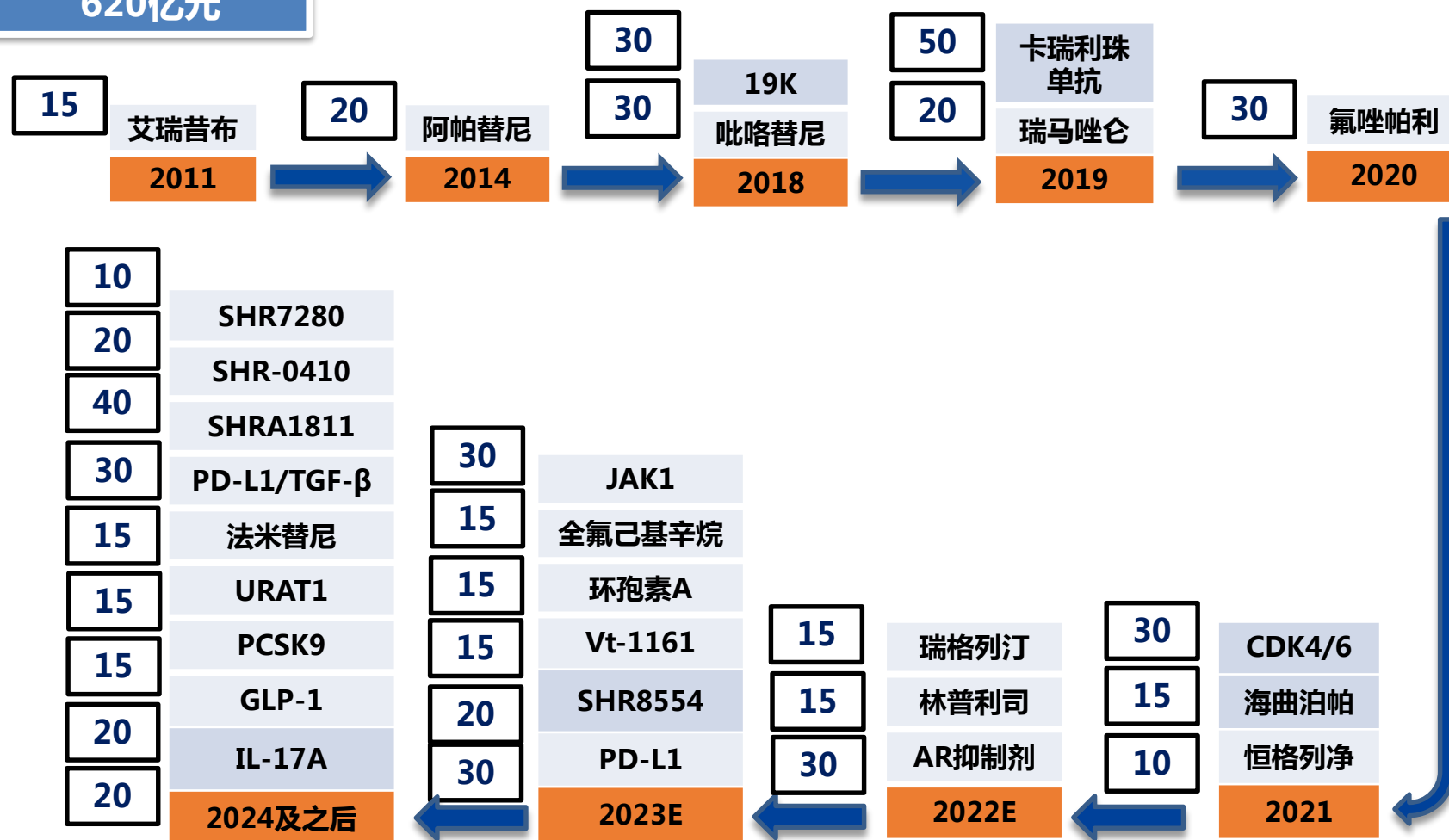
■ 创新升级，关注重磅产品数据

- 公司深耕ADC平台十多年，HER2 ADC SHRA1811对标第一三共DS8201，旨在保持疗效的同时，提升患者的耐受性，建议关注SHRA1811未来发布的疗效和安全性数据，预计2023年有望发布早期数据。

6.5.1 恒瑞医药——创新龙头，业绩拐点将至

销售峰值总计：
620亿元

恒瑞医药创新药商业化节奏



备注：产品左侧数字为产品国内销售峰值预计，单位：亿元

6.5.2 百济神州——营收持续超预期，泽布替尼重磅适应症即将美国获批

■ 核心品种销售放量持续超预期

- 泽布替尼前3季度实现收入25.79亿（同比+206%），其中美国区域实现收入17.55亿（同比+353%），中国区域实现收入7.25亿（同比+59%）；替雷利珠单抗前3季度实现收入21.30亿（同比+64%）；

■ 泽布替尼重磅适应症即将在美国获批

- BTK抑制剂最大的市场在美国，而CLL/SLL是BTK抑制剂份额最大的适应症，此前泽布替尼在美国已经获批MCL、MZL和WM三个适应症，凭借优异的临床效果和强大的商业化能力，泽布替尼在美国MCL新患中的份额超过30%，在美国MZL和WM中，新患份额第一，随着CLL/SLL适应症在美国的获批（决议目标日期为2023年1月），泽布替尼将迎来爆发式增长。

■ BCL2抑制剂已启动二期/潜在注册可用临床试验，适应症包括R/R MCL和R/R CLL/SLL

2018年至今每年有新品种获批的企业情况

产品	主要适应症	作用机制	药政批准状态
泽布替尼 (百悦泽®)	美国: R/R MCL ¹ 、WM 和 R/R MZL ¹ ; 中国: R/R MCL ² 、R/R CLL/SLL ² 和 R/R WM ² ; 欧盟 ³ : WM	BTK抑制剂	美国、中国、欧盟和其他市场已获批
替雷利珠单抗 (百泽安®)	1L 鳞状和非鳞状 NSCLC、2/3 L NSCLC、R/R 经典霍奇金淋巴瘤 ² 、2/3L HCC ² 、R/R PDL1+UC ² 、2L ESCC、MSH-H或 dMMR实体瘤 ² 、NPC	抗PD-1抗体	中国已获批; 美国、欧洲、英国和澳大利亚 ⁴ 已受理上市许可申请
帕米帕利 (百汇泽®)	3L 携带BRCA突变的卵巢癌 ²	PARP抑制剂	中国已获批

6.5.2 百济神州——营收持续超预期，泽布替尼重磅适应症即将美国获批

百济神州在研自主研发临床管线

候选药物	项目	一期临床	二期临床	三期临床
百悦泽® (泽布替尼、BTK)	单药治疗			1L与R/R华氏巨球蛋白血症 (WM) R/R慢性淋巴细胞白血病 (CLL) /小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL)
			成熟B细胞恶性肿瘤 R/R边缘区淋巴瘤 (MZL)	
	+ 利妥昔单抗 + CYP3A抑制剂 +/- 维奈克拉† (Bcl-2 抑制剂) + 奥妥珠单抗 (抗CD20)	B细胞恶性肿瘤		1L套细胞淋巴瘤 (MCL) 与R/R边缘区淋巴瘤 (MZL) 1L慢性淋巴细胞白血病 (CLL) /小淋巴细胞淋巴瘤 (SLL)
			R/R滤泡性淋巴瘤 (FL)	
				2L晚期食管鳞状细胞癌 (ESCC)、1L肝细胞癌 (HCC)、 2L/3L非小细胞肺癌 (NSCLC)
百泽安® (替雷利珠单抗、PD-1)	单药治疗		既往经治肝细胞癌 (HCC)、R/R经典型霍奇金淋巴瘤 (cHL)	1L晚期食管鳞状细胞癌 (ESCC)、1L胃癌 (GC) /胃食管交界癌 (GEJC) 胃食管腺癌 (GEA)
	+ 化疗			
	+ zanidatamab (HER2双抗) + 化疗 + 索凡替尼 (VEGFR、FGFR、CSF-1R) + 呋喹替尼 (VEGFR)*	实体瘤 实体瘤		
				1L PD-L1高表达晚期非小细胞肺癌 (NSCLC)
				1L不可切除非小细胞肺癌 (NSCLC)
欧司珀利单抗 (TIGIT)	+ 替雷利珠单抗		2L PD-L1+ 食管鳞状细胞癌 (ESCC) 2/3L宫颈癌	
		实体瘤		
	+ 替雷利珠单抗 + 化疗		1L非小细胞肺癌 (NSCLC)	
	+ 替雷利珠单抗 + 同步化放疗		1L局限期小细胞肺癌 (SCLC)	
Surzeblimab (BGB-A425、TIM-3)	+ 替雷利珠单抗		实体瘤	
BGB-A445 (OX40)	+ 替雷利珠单抗	实体瘤		
BGB-10188 (PI3K)	+ 替雷利珠单抗		实体瘤	
	+/- 泽布替尼 +/- 替雷利珠单抗		B细胞恶性肿瘤 B细胞恶性肿瘤	
BGB-15025 (HPK1)	+ 替雷利珠单抗	实体瘤		
百汇泽® (帕米帕利、PARP 1/2)	单药治疗 + 替莫唑胺	实体瘤	1L维持治疗铂敏感胃癌 (GC)	
BGB-3245 (BRAF)	单药治疗	带有BRAF突变的实体瘤		
Lifirafenib (RAF)	+ mirdametininib (MEK)	实体瘤		
BGB-11417 (Bcl-2)	+/- 泽布替尼 单药治疗	成熟B细胞恶性肿瘤		
	+ 阿扎胞苷 +/- 泊沙康唑 + 地塞米松 +/- 卡非佐米		R/R套细胞淋巴瘤 (MCL) 髓细胞恶性肿瘤 携带t(11:14)的R/R多发性骨髓瘤 (MM)	
BGB-16673 (BTK CDAC)	单药治疗	B细胞恶性肿瘤		
BGB-23339 (TYK2) **	单药治疗	炎症和免疫		
BGB-24714 (SMAC模拟物) ^	+/- 化疗	实体瘤		
BGB-B167 (CEA x 4-1BB双抗)	+/- 替雷利珠单抗	实体瘤		

■ 源头创新能力是公司的核心竞争力

- 公司具备自主知识产权的ADC平台、抗体和融合蛋白平台、以及双抗平台三大核心技术平台，支撑公司管线布局20余款候选生物药产品，其中7款已进入临床阶段，泰它西普和维迪西妥单抗的成功商业化证明了公司超强的源头创新能力，国际化是源头创新的终极价值体现，如2021年8月荣昌将维迪西妥单抗授权给与Seagen Inc，授权费用也刷新了单药海外授权新纪录。

■ 泰它西普多项适应症不断推进

- 泰它西普针对中度和重度类风湿性关节炎的III期临床预计2022年底结束，2023年上半年有望提交新适应症的申请，另外还有包括视神经脊髓炎频谱系疾病和系统性红斑狼疮（美国）处于III期临床，IgA肾炎、干燥综合症（SS）和重症肌无力（MG）等三项适应症结束II期临床，即将开展III期临床，适应症得增多，将大大提升产品终端的目标患者群体。

■ 维迪西妥正计划在美国启动多个III期临床

- 维迪西妥单抗目前在美国已经启动二线HER2表达尿路上皮癌的II期临床，另外公司正在计划启动联合PD-1治疗一线乳腺癌和联合PD-1治疗一线尿路上皮癌的III期临床。国内治疗HER2低表达乳腺癌的III期临床预计最快2023年上半年完成入组，HER2低表达乳腺癌是维迪西妥最大的适应症群体，公司进度远超国内同行。

6.5.3 荣昌生物——具有源头创新能力的科创小黑马

荣昌生物研发管线

产品	靶点	方式	适应症	进度	试验地区
泰它西普	BlyS/APRIL	融合蛋白	系统性红斑狼疮 (SLE)	获批	中国
			系统性红斑狼疮	III期	美国
			视神经脊髓炎频谱系疾病/NMOSD	III期	中国
			MTX 疗效不佳的中度和重度类风湿性关节炎 (RA)	III期	中国
			IgA肾炎	II期完成	中国
			IgA肾炎	II期	美国
			干燥综合症 (SS)	II期完成	中国
维迪西妥单抗	HER2	ADC	多发性硬化症 (MS)	II期	中国
			重症肌无力 (MG)	II期	中国
			HER2表达胃癌	获批	中国
			HER2表达尿路上皮癌	获批	中国
			联合PD-1治疗围手术期HER2表达浸润性膀胱癌	II期	中国
			联合PD-1治疗一线尿路上皮癌	III期	中国
			二线HER2表达尿路上皮癌	II期	美国
			联合PD-1治疗一线尿路上皮癌	IND	美国, III期计划中
			HER2表达胃癌 (GC)	IND批准	美国, III期计划中
			联合PD-1治疗一线乳腺癌	IND	美国, III期计划中
			HER2低表达乳腺癌	III期	中国
			HER2 阳性乳腺癌伴或不伴肝转移 (BC)	II/III期	中国
			HER2低及不表达尿路上皮癌	II期	中国
			HER2 表达 (阳性和低表达) 妇科恶性肿瘤	II期	中国
			HER2过表达胆道癌	II期	中国
			HER2表达非小细胞肺癌	I/II期	中国
			HER2阳性晚期黑色素瘤	II期	中国
RC108	c-MET	ADC	联合RC98 PD-L1治疗胃癌	I期	中国
RC118	Claudin18.2	ADC	c-Met 阳性晚期恶性实体瘤	I期	中国
RC88	间皮素 (MSLN)	ADC	Claudin 18.2表达阳性的晚期恶性实体瘤	I/II期	中国
RC98	PD-L1	mAb	多种实体瘤	I期	澳大利亚
RC138	保密	HiBody	胸膜间皮瘤和 MSLN 阳性晚期恶性实体瘤	I/II期	中国
RC148	保密	HiBody	肺癌、尿路上皮癌及其他实体瘤	I期	中国
RC158	保密	HiBody	多种实体瘤	IND	
RC28	VEGF/FGF	融合蛋白	多种实体瘤	IND	
			湿性老年性黄斑病变 (wAMD)	I期完成	中国
			糖尿病黄斑水肿 (DME)	II期	中国
			糖尿病视网膜膜病变 (DR)	II期	中国

销售峰值

泰它西普——基于SLE、NMOSD、RA、IgA肾病和SS，预计国内峰值有望达到50亿元；基于SLE，预计美国市场峰值有望达到5亿美金；

维迪西妥单抗——基于胃癌、尿路上皮癌、HER2低表达乳腺癌，预计国内峰值有望达到40亿；基于胃癌和尿路上皮癌，预计美国市场峰值有望达到4亿美金。

6.5.4 盟科药业——超级抗生素第一股

■ 康替唑胺——首个国产超级抗生素，市场潜力20亿元

- 康替唑胺片是盟科药业研发的首个治疗耐G+菌的超级抗生素，也是首个国产超级抗生素，相较万古霉素和利奈唑胺，具有更优的安全性，对骨髓的抑制以及肾脏的毒性都非常小，解决了临床众多住院患者用药受限的问题。预计未来国内超级抗生素的使用天数有望达到2000万天，康替唑胺（包括注射剂）有望拿到25%左右的市场份额，峰值空间超过20亿。另外康替唑胺片及其注射剂也在开展包括美国在内的全球多中心III期临床，有望2024年结束临床，向国内外监管机构提交上市申请。

盟科药业研发管线

项目	药物类型	主要适应症	早期研发	临床前研究	I期	II期	III期	上市	地区	备注
康替唑胺 (MRX-1)	噁唑烷酮类	复杂性皮肤和软组织感染							中国	2021年6月 NDA获批
		急性细菌性皮肤和皮肤结构感染、糖尿病足感染							全球多中心	国际多中心III期进行中
MRX-4	噁唑烷酮类	急性细菌性皮肤和皮肤结构感染、糖尿病足感染							全球多中心	国际多中心III期进行中
MRX-8	多粘菌素类	耐药革兰阴性菌感染							中国	临床I期试验进行中
									美国	临床I期试验进行中
MRX-5	硼烷类	耐药细菌感染								
MRX-7	截短侧耳素									
MRX-15	药物偶联物	肾癌								
MRX-17	药物偶联物	肾炎								
MRX-18	蛋白酶抑制剂	新冠病毒感染								

销售峰值

康替唑胺及其注射剂——国内峰值预计20亿元；美国峰值预计6亿美元。

6.5.5 君实生物——新冠小分子药进入最后关键研发阶段

■ VV116——多项3期临床研究全力推进，重点关注国内III期临床进度

- VV116目前已经完成一项国内III期临床试验（对照药为Paxlovid）且取得了阳性结果，另外有三个III期临床正在开展，建议关注国内开展的针对轻症患者的以安慰剂为对照的III期临床试验，目前国内患者增多，入组加快，有望于2023年年初达到试验终点，提交EUA申请。

■ 特瑞普利单抗——国内最强术后辅助/围手术期布局

- 广泛布局术后辅助/围手术期领域，覆盖全国高发癌种，包括胃癌、肝癌、肺癌、食管鳞癌，目前皆进入临床试验3期阶段，有望2023年HCC术后辅助治疗和NSCLC围手术期III期临床结束提交上市申请。

君实生物研发管线

临床前			临床一期			临床二期	临床三期	已批准
JS011 未予披露 肿瘤	JS120 IDH1 肿瘤	JS209 CD112R+TIGIT 肿瘤	JS001sc PD-1 肿瘤	JS019 CD39 肿瘤	JS112 Aurora A 小细胞肺癌	Tifcemalimab BTLA 肺癌 黑色素瘤等	JS109 PARP 卵巢癌	特瑞普利单抗 PD-1 肿瘤 ✓
JS013 CD93 肿瘤	JS121 SHP2 肿瘤	JS211 PD-L1+未予披露 肿瘤	JS003 PD-L1 肿瘤	JS101 Pan-CDK 乳腺癌等	JS113 EGFR 4th Gen 非小细胞肺癌	JS005 IL-17A 银屑病 脊柱炎	贝伐珠单抗 VEGF 非小细胞肺癌	阿达木单抗 TNF-α 类风湿关节炎等 ✓
JS015 DKK1 肿瘤	JS122 FGFR2 肿瘤	JS008 未予披露	JS006(TAB006) TIGIT 肿瘤	JS105 PI3K-α 乳腺癌 肾细胞癌	JS116 KRAS 肿瘤		恩戈瑞单抗 PCSK9 高脂血症	埃特司韦单抗* S蛋白 新型冠状病毒
JS018 IL-2 肿瘤	JS123 ATR 肿瘤	JS401 未予披露 (RNAi) 代谢疾病	JS007 CTLA-4 肿瘤 黑色素瘤	JS107 Claudin18.2 ADC 消化道肿瘤	JS201 PD-1+TGF-β 肿瘤		JT001(VV116) RdRp 新型冠状病毒	
JS104 Pan-CDK 乳腺癌等	JS205 EGFR+cMet 肿瘤	JS010 CGRP 偏头痛	JS009(TAB009) CD112R/PPVIRIG 肿瘤	JS108 TROP2 ADC 三阴性乳腺癌	JS203 CD3+CD20 肿瘤			
JS114 Nectin4 ADC 肿瘤	JS206 IL2+PD-1 肿瘤	JT003(VV993) 3CL蛋白酶 新型冠状病毒	JS012 Claudin 18.2 胃癌	JS110 XPO1 多发性骨髓瘤等	JS103 Uricase 高尿酸血症			
JS115 BCMA ADC 多发性骨髓瘤	JS207 PD-1+VEGF 肿瘤	JT109 疫苗 寨卡病毒	JS014 IL-21 肿瘤	JS111 EGFR exon 20 非小细胞肺癌	UBP1213sc BlyS 系统性红斑狼疮			
					JS026 S蛋白 新型冠状病毒			



*已获得FDA紧急使用授权

销售峰值

VV116——根据美国新冠药的使用量，推算国内新冠药使用量，预计国内有1亿人份的使用量，假设1人份200元 vv116市占率50%，则峰值在100亿左右。

特瑞普利单抗——国内峰值预计50亿（围手术期适应症预计为30亿）；基于鼻咽癌美国峰值预计2亿美金。

6.5.6 泽璟制药——管线进入集中收获期

■ 多纳非尼持续放量

- 多纳非尼是目前唯一一个在专利期内治疗一线肝癌的靶向创新药，也是唯一一个相比索拉非尼单药显示优效的药物，已被纳入多个行业指南，成为一线肝癌的最优推荐，上市后，公司开展了多个与PD-1/PD-L1、或与介入和化疗等联用的真实世界研究，推动多纳非尼的放量；

■ 杰克替尼上市获受理，疗效和安全性优势显著，预计2023年获批上市

- 杰克替尼的中、高危骨髓纤维化NDA申请已于10月16号获得受理，针对芦可替尼不耐受的中、高危骨髓纤维化注册临床试验亦取得成功，后续将提交上市申请，国内骨髓纤维化患者年新发约6万，存量患者数预计约30万人，中国骨髓纤维化的靶向药目前仅有一款产品芦可替尼，于2016年进入国内市场，杰克替尼相较芦可替尼具有更高的有效率和更低的贫血发生率，杰克替尼有望成为骨髓纤维化市场的主导产品之一；另外杰克替尼还有包括斑秃、强制性脊柱炎等多个慢性疾病处于II期和III期临床阶段，将进一步扩大杰克替尼的目标患者群体；

■ 首个外用重组人凝血酶NDA获国家药监局受理，预计2023年获批上市

- 公司的外用重组人凝血酶是目前国内唯一采用重组基因技术生产的重组人凝血酶，相较于其他来源生物止血材料，公司的重组人凝血酶具有特异性更高、疗效更好的同时，免疫原性和感染等风险也更低，且商业化成本更低，将可能替代外科手术局部止血传统生物药品，市场潜力大，有望填补国内市场空白，满足迫切的临床需求。目前，重组人凝血酶的临床现场核查和生产现场核查已经完成，有望于2023年获批上市。

6.5.6 泽璟制药——管线进入集中收获期

泽璟制药物研发管线

产品	靶点	类别	适应症	进度
多纳非尼	Raf、MEK、ERK ; VEGFR、PDGFR	小分子	肝癌一线	获批上市
			甲状腺癌（局部晚期/转移性放射性碘难治性分化型甲状腺癌）	获批上市
			复发性急性髓系白血病	II期完成
			肝癌辅助治疗	II
奥卡替尼	ALK/ROS1	小分子	与抗体类肿瘤免疫治疗药物联合	II
ZG19018	KRAS G12C	小分子	克唑替尼耐药的NSCLC	II
ZG170607	TLR8	小分子	KRAS G12C 突变的晚期实体瘤	I / II
ZG005	PD-1/TIGIT	双抗	KRAS G12C 突变的晚期实体瘤	II期，美国
ZG006	CD3/DLL3		晚期实体瘤	临床前
GS11	TAA/CD3		小细胞肺癌，DLL3高表达	I/II
GS15	免疫双靶点			II期，美国
ZGGS18	VEGF/TGF-β		晚期实体瘤	临床前
ZGGS001	免疫三靶点	三抗	晚期实体瘤	I
重组人促甲状腺激素	TSH	复杂重组蛋白	晚期实体瘤	II期，美国
			甲状腺癌辅助诊断	临床前
			甲状腺癌辅助治疗	III
			中、高危骨髓纤维化	III
			中重度特应性皮炎	报产
			芦可替尼不耐受的骨髓纤维化	III
			芦可替尼复发/难治的骨髓纤维化	II
			重型新型冠状病毒肺炎	II
			活动性强直性脊柱炎	I
			特发性肺纤维化	II
杰克替尼	JAK1/2/3	小分子	中重度斑块状银屑病	II
			重症斑秃	II
			重症斑秃	III
			骨髓纤维化	美国IND
			急性移植物抗宿主病	美国II期
			慢性移植物抗宿主病	II
			轻中度斑秃（外用）	I
			轻、中度特应性皮炎（外用）	II
			在肝脏切除术后辅助止血	I/II
			止血（外用）	报产
外用重组人凝血酶 ZG1905	Thrombin	复杂重组蛋白		临床前
奥贝胆酸镁片	FXR	小分子	对熊去氧胆酸应答不佳的原发性胆汁性胆管炎	I

销售峰值

多纳非尼——
国内峰值预计
15亿元；

杰克替尼——
基于骨髓纤维
化、中重度特
应性皮炎和重
症斑秃，预计
国内销售峰值
为30亿元；

**重组人凝血
酶——**预计国
内销售峰值为
10亿元。

主要内容

1. 2022板块复盘：四季度反弹趋势走稳
2. 2022行业运行：需求、支付端平稳，创新药出现供给侧变化
3. 2022行业政策：集采负面影响渐散
4. 2022行业政策：支付端改革进入深水区
5. 2022行业政策：疫情防控措施持续优化
6. 2023重点推荐：创新药-未来已来
7. 投资分析意见及风险提示

7.1 投资分析意见

- 在集采降价、上年新冠相关产业基数扰动的双重影响下，医药生物（申万）板块今年仍维持了稳健增长，前三季度板块营收同比增长9%，归母净利润同比增长7%。目前整体板块的估值仍处于底部，多数子板块估值仍远低于集采及疫情前水平。
- 从医院终端的诊疗人数及药品销售额来看，今年上半年在疫情的持续影响下仍维持小幅增长，而在年末防疫政策的积极优化下，我们预计明年板块业绩表现有可能恢复甚至超出2019年同期水平。
- 集采政策对板块的冲击影响接近尾声，我们预计未来无论是集采的节奏还是相关品种的降幅都会出现较大缓和，如今年下半年多个新出台集采政策均显示出边际放缓的变化。
- 创新药板块进入从“量变”到“质变”的关键阶段，数十家创新药企业此前在2020年，2021年获批的新品有望在未来帮助一批Biotech公司扭亏为盈。
- 我们认为生物医药板块在底部估值区间仍具极高的投资配置价值，推荐关注创新药板块，建议关注：恒瑞医药、百济神州、荣昌生物、盟科药业、泽璟制药。

7.2 风险提示

- **新冠疫情风险**：当前国内疫情呈现多点散发的形势，而本轮疫情主要来自于Omicron变异株传播，该变异株具有较强的免疫逃逸能力和传染性，可能对院内渠道及零售渠道的终端需求形成压制。
- **新冠产业业务订单的可持续性**：由于新冠疫情反复，上市公司涉及新冠疫情防控、新冠疫苗、新冠药物研发和生产、新冠检测的相关订单可能因国内防疫政策变化存在不确定性和不可持续性。
- **集采风险**：上市公司药品在集采竞价中存在落选风险，即使通过降价中标获得部分省区报量之后，仍可能因为中选价格过低等因素对公司业绩造成不良影响。
- **新药研发风险**：新药研发存在较大不确定性，从临床前研究的靶点确定和化合物合成再到临床试验，最后到申报上市其中时间间隔可长达数年甚至十数年之久，存在较高风险。
- **新药审批不确定性风险**：新药审批结果具有不确定性。即便已经获批适用于某些适应症、也不代表一定能够获批适用于新的适应症。研究人员仅能根据监管部门对于新药审批的时长要求估计审批结果公布的时间，无法事前知晓审批结果。

重点公司估值表

证券代码	证券简称	2022/12/13		预测EPS(元)				PE		
		收盘价(元)	总市值(亿元)	2021A	2022E	2023E	2024E	2022E	2023E	2024E
300760.SZ	迈瑞医疗	312.42	3788	6.60	8.03	9.90	11.91	39	32	26
600276.SH	恒瑞医药	38.38	2448	0.71	0.68	0.78	0.93	57	49	41
603259.SH	药明康德	78.80	2289	1.72	3.03	3.59	4.60	26	22	17
300015.SZ	爱尔眼科	28.65	2056	0.32	0.39	0.54	0.69	73	53	42
688271.SH	联影医疗	165.30	1362	1.72	2.20	2.85	3.54	75	58	47
300122.SZ	智飞生物	87.21	1395	6.38	4.55	5.87	6.95	19	15	13
000538.SZ	云南白药	59.00	1060	1.56	3.60	4.09	4.62	16	14	13
300347.SZ	泰格医药	88.65	748	3.29	3.73	4.63	5.72	24	19	15
000661.SZ	长春高新	177.21	717	9.28	12.89	15.64	-	14	11	-
002821.SZ	凯莱英	135.16	486	2.89	8.44	7.82	9.17	16	17	15
300529.SZ	健帆生物	32.27	261	1.48	1.67	2.20	2.87	19	15	11
300601.SZ	康泰生物	34.92	391	1.13	0.29	1.50	2.20	120	23	16
688185.SH	康希诺	185.70	314	7.74	2.89	3.69	5.98	64	50	31
603520.SH	司太立	20.38	70	0.94	2.03	2.68	3.34	10	8	6
603707.SH	健友股份	17.34	280	0.66	1.17	1.51	-	15	11	-
300357.SZ	我武生物	52.26	274	0.65	0.80	1.00	1.26	65	52	41
688050.SH	爱博医疗	215.75	227	1.63	2.40	3.38	4.61	90	64	47
688166.SH	博瑞医药	22.69	96	0.58	0.71	0.91	1.30	32	25	17
300630.SZ	普利制药	28.50	124	0.95	1.37	1.78	2.33	21	16	12
688198.SH	佰仁医疗	142.69	194	0.38	0.99	1.67	2.75	144	85	52
688029.SH	南微医学	90.19	169	1.73	3.01	3.92	4.87	30	23	19
688356.SH	键凯科技	147.77	89	2.92	3.85	5.09	6.69	38	29	22

资料来源：Wind，申万宏源研究

备注：其中恒瑞医药、普利制药和键凯科技取 wind 一致预测，其他公司取申万盈利预测。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swhysc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swhysc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swhysc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swhysc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）：	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。
本报告采用的基准指数	：恒生中国企业指数（HSCEI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国内地（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

张静含
zhangjh@swsresearch.com